UE B2 S1 · SEMESTRE 1 · COURS ET SUPPORTS OFFICIELS

Psychologie de la santé — QCM

Pour chaque question, cochez les bonnes propositions parmi A à E. Il peut y avoir une, deux ou trois réponses exactes. Les corrigés argumentés suivent les 62 questions.

62 questions | 12 compléments officiels | Corrigés à la fin

Santé et qualité de vie — 6 questions

Q01 — La psychologie de la santé étudie notamment… — Facile

- ☐ A. les seuls résultats biologiques.
- ☐ B. les déterminants biologiques, psychologiques et sociaux.
- ☐ C. le vécu subjectif de la maladie.
- ☐ D. uniquement la prescription médicale.
- ☐ E. les comportements de santé.

Q02 — Que faut-il retenir de la définition de la santé formulée par l'OMS ? — Facile

- ☐ A. Elle inclut le bien-être physique.
- ☐ B. Elle se réduit à l'absence de maladie.
- ☐ C. Elle inclut le bien-être mental et social.
- ☐ D. Elle impose une mesure biologique unique.
- ☐ E. Sa notion de « complet bien-être » peut être discutée.

Q03 — À propos de la santé perçue, quelles propositions sont justes ? — Moyen

- ☐ A. Elle correspond à l'évaluation que le patient fait de sa propre santé.
- ☐ B. Elle est toujours identique aux examens.
- ☐ C. Elle dépend du vécu personnel.
- ☐ D. Elle peut différer de l'évaluation des professionnels.
- ☐ E. Elle exclut les émotions.

Q04 — Facile

Quelles dimensions font partie de la qualité de vie ?

- [ ] **A.** le fonctionnement physique.
- [ ] **B.** la situation sociale.
- [ ] **C.** les ressources et le logement.
- [ ] **D.** uniquement les constantes vitales.
- [ ] **E.** exclusivement la durée du traitement.

Q05 — Moyen

Une personne vit avec une maladie chronique et dit garder une bonne qualité de vie. Que peut-on conclure ?

- [ ] **A.** Cette appréciation peut être authentique.
- [ ] **B.** Elle prouve l'absence de maladie.
- [ ] **C.** La qualité de vie est subjective et multidimensionnelle.
- [ ] **D.** Les professionnels doivent nécessairement la corriger.
- [ ] **E.** L'évaluation personnelle doit être entendue.

Q06 — Difficile

Lorsqu'une infirmière et un patient évaluent différemment la santé de ce dernier…

- [ ] **A.** l'hétéro-évaluation peut différer de l'auto-évaluation.
- [ ] **B.** il faut exclure la parole du patient.
- [ ] **C.** il faut explorer les raisons de l'écart.
- [ ] **D.** la perception du patient devient forcément fausse.
- [ ] **E.** les deux regards peuvent éclairer la situation.

Maladie, douleur et représentations — 6 questions

Q07 — Facile

Dans la distinction disease / illness / sickness, illness désigne…

- [ ] **A.** l'expérience subjective de la maladie.
- [ ] **B.** la seule classification diagnostique.
- [ ] **C.** le sens vécu et exprimé par la personne.
- [ ] **D.** exclusivement l'évolution biologique.
- [ ] **E.** un concept identique au terme disease.

Q08 — **La notion de sickness se rapporte notamment…** — Facile

- ☐ **A.** à la reconnaissance sociale de la maladie.
- ☐ **B.** à la stigmatisation éventuelle.
- ☐ **C.** aux relations entre maladie et contexte culturel.
- ☐ **D.** uniquement à une prise de sang.
- ☐ **E.** seulement à la douleur ressentie.

Q09 — **Quelles affirmations correspondent à l'approche de la douleur présentée ?** — Moyen

- ☐ **A.** Elle comporte une dimension sensorielle.
- ☐ **B.** Une douleur nécessite toujours une lésion prouvée.
- ☐ **C.** Elle comporte une dimension émotionnelle.
- ☐ **D.** Une absence d'anomalie à l'examen permet de la nier.
- ☐ **E.** Elle est personnelle et subjective.

Q10 — **Un patient exprime une douleur sans anomalie identifiée. Quelle posture est adaptée ?** — Difficile

- ☐ **A.** Accueillir la plainte sans disqualification.
- ☐ **B.** Dire que le patient simule.
- ☐ **C.** Évaluer et transmettre le vécu douloureux.
- ☐ **D.** Déduire que la cause est exclusivement psychique.
- ☐ **E.** Chercher une prise en charge adaptée.

Q11 — **Les représentations personnelles de la maladie peuvent concerner…** — Moyen

- ☐ **A.** sa cause supposée.
- ☐ **B.** son avenir et sa durée.
- ☐ **C.** les possibilités de la contrôler.
- ☐ **D.** seulement son code diagnostique.
- ☐ **E.** uniquement les paroles du soignant.

Q12 — Difficile

Une personne associe sa maladie à une épreuve familiale et refuse un soin. Que doit faire le soignant ?

- ☐ **A.** Explorer le sens donné à la maladie.
- ☐ **B.** Conclure à une mauvaise volonté certaine.
- ☐ **C.** Distinguer croyance personnelle et cause médicalement établie.
- ☐ **D.** Nier immédiatement toute inquiétude.
- ☐ **E.** Rechercher les besoins de contrôle du patient.

Déterminants et modèle intégratif — 4 questions

Q13 — Facile

Quels niveaux sont articulés dans le modèle intégratif de la santé ?

- ☐ **A.** des prédicteurs.
- ☐ **B.** des modérateurs transactionnels.
- ☐ **C.** des issues ou critères d'ajustement.
- ☐ **D.** uniquement une cause génétique.
- ☐ **E.** une certitude de maladie à partir d'un seul facteur.

Q14 — Moyen

Un facteur de risque…

- ☐ **A.** augmente une probabilité sans déterminer le destin individuel.
- ☐ **B.** permet de prédire à coup sûr un diagnostic.
- ☐ **C.** peut être personnel ou environnemental.
- ☐ **D.** doit être distingué d'un déclencheur ou stresseur.
- ☐ **E.** rend inutile l'étude des ressources protectrices.

Q15 — Moyen

Parmi les éléments suivants, lesquels sont des déterminants socio-environnementaux abordés ?

- ☐ **A.** la qualité du logement.
- ☐ **B.** l'accès aux soins.
- ☐ **C.** les ressources économiques.
- ☐ **D.** une affirmation que la culture suffit à expliquer une maladie.
- ☐ **E.** l'absence de toute inégalité de santé.

Q16 — Difficile

Une personne fait face à la même contrainte qu'une autre mais la vit différemment. Qu'est-ce qui l'explique dans ce modèle ?

- A. la façon d'évaluer la situation.
- B. les ressources perçues et mobilisées.
- C. l'histoire personnelle.
- D. une réaction obligatoirement identique pour tous.
- E. l'impossibilité d'agir sur l'expérience du stress.

Soutien social

5 questions

Q17 — Facile

Le réseau social d'une personne correspond…

- A. aux personnes avec lesquelles elle entretient des relations.
- B. à une garantie de soutien utile.
- C. à l'ensemble de ses contacts et liens.
- D. au sentiment d'être aidée uniquement.
- E. exclusivement aux professionnels de santé.

Q18 — Moyen

Le soutien social perçu désigne…

- A. l'appréciation subjective de la disponibilité d'une aide.
- B. uniquement le nombre de contacts.
- C. le sentiment de pouvoir compter sur un soutien adapté.
- D. une mesure obligatoirement égale au soutien reçu.
- E. la qualité de l'aide telle que la personne l'imagine.

Q19 — Moyen

Le soutien social reçu et le soutien mobilisé se distinguent parce que…

- A. le soutien reçu correspond à l'aide effectivement apportée.
- B. le soutien mobilisé implique une démarche de sollicitation.
- C. ils sont toujours identiques au soutien perçu.
- D. ils ne concernent jamais l'aide matérielle.
- E. une personne peut solliciter du soutien sans se sentir soutenue.

Q20 — Quelles situations correspondent à des formes de soutien social ? — Facile

- [ ] **A.** Une aide matérielle pour le logement.
- [ ] **B.** Une écoute empathique.
- [ ] **C.** Une information pratique pour décider.
- [ ] **D.** Une relation nécessairement contraignante.
- [ ] **E.** L'obligation de n'obtenir que l'aide familiale.

Q21 — Une personne a beaucoup de connaissances mais dit « personne ne m'aide quand ça va mal ». Quelles pistes sont pertinentes ? — Difficile

- [ ] **A.** Explorer la qualité du soutien perçu.
- [ ] **B.** Déduire automatiquement que son soutien est suffisant.
- [ ] **C.** Distinguer quantité de relations et disponibilité réelle.
- [ ] **D.** Examiner la possibilité de demander une aide adaptée.
- [ ] **E.** Répondre que son ressenti est faux car son carnet d'adresses est rempli.

Vulnérabilité et résilience — 5 questions

Q22 — La vulnérabilité peut dépendre… — Facile

- [ ] **A.** de caractéristiques individuelles.
- [ ] **B.** du contexte relationnel et socio-économique.
- [ ] **C.** de ressources et carences de l'environnement.
- [ ] **D.** uniquement de l'âge.
- [ ] **E.** exclusivement de la volonté.

Q23 — La résilience présentée en cours… — Moyen

- [ ] **A.** suppose qu'une épreuve ou une adversité a été rencontrée.
- [ ] **B.** signifie une invulnérabilité permanente.
- [ ] **C.** renvoie à la capacité de poursuivre une construction.
- [ ] **D.** peut mobiliser des ressources extérieures.
- [ ] **E.** garantit l'absence de souffrance.

Q24 — **À propos des formulations de Rutter et de Cyrulnik…** — Moyen

- [ ] **A.** elles insistent sur la poursuite du développement ou de la vie après l'adversité.
- [ ] **B.** une citation partielle suffit à l'examen selon Mme Katir.
- [ ] **C.** Plusieurs définitions de la résilience sont complémentaires.
- [ ] **D.** leurs formulations sont à restituer en phrases complètes.
- [ ] **E.** elles excluent les facteurs environnementaux.

Q25 — **Les travaux longitudinaux d'Emmy Werner sont évoqués pour…** — Moyen

- [ ] **A.** illustrer des trajectoires adaptées malgré certains facteurs de risque.
- [ ] **B.** affirmer que tous les enfants exposés deviennent malades.
- [ ] **C.** montrer l'importance de facteurs protecteurs.
- [ ] **D.** établir que la résilience est identique pour tous.
- [ ] **E.** aider à réfléchir au devenir dans le temps.

Q26 — **Que peut-on affirmer au sujet des traits de personnalité et de l'hostilité ?** — Difficile

- [ ] **A.** Un trait isolé ne permet pas d'établir qu'il cause une maladie.
- [ ] **B.** L'hostilité associe des composantes cognitives, émotionnelles et comportementales.
- [ ] **C.** Une attitude hostile justifie un jugement moral du soignant.
- [ ] **D.** La méfiance peut modifier l'évaluation d'une situation.
- [ ] **E.** Un trait rend toute intervention inutile.

Stress et coping — 7 questions

Q27 — **Dans le modèle transactionnel du stress, l'évaluation primaire porte sur…** — Facile

- [ ] **A.** la signification de la situation pour la personne.
- [ ] **B.** les ressources disponibles exclusivement.
- [ ] **C.** une menace, une perte ou un défi.
- [ ] **D.** le diagnostic biologique certain.
- [ ] **E.** l'appréciation de l'événement vécu.

Q28 **L'évaluation secondaire concerne notamment…** Moyen

- [ ] **A.** les ressources personnelles estimées.
- [ ] **B.** les aides sociales disponibles.
- [ ] **C.** les possibilités d'agir.
- [ ] **D.** la nature anatomique obligatoire de la maladie.
- [ ] **E.** la certitude de maîtriser tous les événements.

Q29 **Le contrôle perçu…** Moyen

- [ ] **A.** renvoie à une représentation de sa capacité d'agir.
- [ ] **B.** est toujours identique au contrôle objectif.
- [ ] **C.** peut porter sur les conséquences de la situation.
- [ ] **D.** peut porter sur ses propres réactions.
- [ ] **E.** rend toujours inutile le soutien des proches.

Q30 **Le coping centré sur le problème peut consister à…** Facile

- [ ] **A.** chercher des informations fiables.
- [ ] **B.** planifier une action possible.
- [ ] **C.** agir concrètement sur la difficulté.
- [ ] **D.** nier obligatoirement toute réalité.
- [ ] **E.** considérer toute émotion comme interdite.

Q31 **Le coping centré sur l'émotion peut inclure…** Facile

- [ ] **A.** une réévaluation positive.
- [ ] **B.** des stratégies de mise à distance.
- [ ] **C.** des efforts pour gérer la réponse émotionnelle.
- [ ] **D.** uniquement la réparation du problème matériel.
- [ ] **E.** le refus de ressentir toute émotion comme définition unique.

Q32 — **Le coping centré sur la recherche de soutien comprend…** — Moyen

- [ ] **A.** demander une écoute.
- [ ] **B.** chercher des conseils.
- [ ] **C.** solliciter une aide matérielle.
- [ ] **D.** ne jamais parler à l'entourage.
- [ ] **E.** remplacer systématiquement la décision médicale par l'opinion d'un proche.

Q33 — **Comment distinguer les stratégies de coping et les mécanismes de défense ?** — Difficile

- [ ] **A.** Le coping est décrit comme des efforts cognitifs et comportementaux d'ajustement.
- [ ] **B.** Les mécanismes de défense sont présentés comme largement inconscients.
- [ ] **C.** Ils sont exactement synonymes.
- [ ] **D.** La pertinence d'une stratégie dépend du contexte.
- [ ] **E.** Toute stratégie de coping est toujours efficace.

Angoisse et mécanismes de défense — 8 questions

Q34 — **Les mécanismes de défense ont principalement pour fonction…** — Facile

- [ ] **A.** de protéger le psychisme face à une angoisse ou un conflit difficile.
- [ ] **B.** de garantir l'absence de maladie.
- [ ] **C.** de ménager parfois du temps pour intégrer l'événement.
- [ ] **D.** de refléter des processus essentiellement inconscients.
- [ ] **E.** de prouver une mauvaise volonté du patient.

Q35 — **Un patient paraît dans le déni après une annonce. Quelles attitudes sont cohérentes avec le cours ?** — Moyen

- [ ] **A.** Respecter la fonction potentiellement protectrice de la défense.
- [ ] **B.** Forcer immédiatement toute prise de conscience.
- [ ] **C.** Évaluer l'impact du déni sur la sécurité et l'accès aux soins.
- [ ] **D.** Écouter avant d'interpréter.
- [ ] **E.** Qualifier le patient de manipulateur.

Q36 — **La projection peut être décrite comme…** — Moyen

- [ ] **A.** l'attribution à l'extérieur de pensées ou affects refusés en soi.
- [ ] **B.** une simple demande de précision.
- [ ] **C.** un mécanisme dont l'expression peut prendre la forme de reproches.
- [ ] **D.** une preuve que les soignants sont réellement responsables de toute difficulté.
- [ ] **E.** un mécanisme de défense évoqué en cours.

Q37 — **À propos de la régression et de la rationalisation…** — Moyen

- [ ] **A.** la régression renvoie à des modes de fonctionnement antérieurs.
- [ ] **B.** la rationalisation produit une justification apparemment logique masquant des motifs inconscients.
- [ ] **C.** ces mécanismes s'expriment toujours consciemment et volontairement.
- [ ] **D.** ils figurent dans le chapitre des défenses.
- [ ] **E.** ils excluent toute angoisse.

Q38 — **Quelle distinction est correcte entre isolation, refoulement et dénégation ?** — Difficile

- [ ] **A.** L'isolation sépare un affect d'une représentation qui reste consciente.
- [ ] **B.** Le refoulement rejette certaines représentations conflictuelles dans l'inconscient.
- [ ] **C.** La dénégation consiste à refuser comme siens des contenus venant d'être exprimés.
- [ ] **D.** Les trois notions sont totalement identiques.
- [ ] **E.** Elles constituent des diagnostics psychiques suffisants.

Q39 — **À propos de l'activisme, de la combativité et du retrait apathique…** — Moyen

- [ ] **A.** l'activisme recourt à l'action plutôt qu'au vécu des affects.
- [ ] **B.** la combativité peut être une forme d'activisme.
- [ ] **C.** le retrait apathique se présente comme une protection par détachement.
- [ ] **D.** ces réactions doivent être jugées négativement dans tous les cas.
- [ ] **E.** la combativité garantit la guérison somatique.

Q40 — **L'affiliation présentée comme mécanisme de défense…** — Difficile

- [ ] **A.** cherche l'aide et le soutien d'autrui en situation anxiogène.
- [ ] **B.** correspond exactement à toutes les définitions d'affiliation en psychologie sociale.
- [ ] **C.** est à distinguer du concept social de formation des liens.
- [ ] **D.** peut être mobilisée pour faire face à une épreuve.
- [ ] **E.** est synonyme d'isolement obligatoire.

Q41 — **La sublimation et l'humour sont abordés dans les défenses. Quelles propositions sont justes ?** — Difficile

- [ ] **A.** La sublimation peut dériver une pulsion vers des activités valorisées.
- [ ] **B.** L'humour appliqué à soi-même peut avoir une fonction défensive.
- [ ] **C.** La sublimation se résume à une perte de mémoire.
- [ ] **D.** La notion de sublimation comporte deux acceptions distinctes.
- [ ] **E.** L'humour signifie nécessairement se moquer du patient.

Annonce du diagnostic — 4 questions

Q42 — **La définition complète de l'annonce du diagnostic donnée par Mme Katir comporte…** — Facile

- [ ] **A.** l'acte médical d'informer le patient.
- [ ] **B.** un choc psychologique possible et un bouleversement.
- [ ] **C.** la prise en compte du patient et de ses proches.
- [ ] **D.** une simple formalité administrative sans conséquence.
- [ ] **E.** la certitude que tous les patients vont réagir de la même façon.

Q43 — **Concernant les réactions décrites après une annonce…** — Moyen

- [ ] **A.** le cours évoque la sidération et le déni.
- [ ] **B.** il évoque colère, marchandage, état dépressif et acceptation.
- [ ] **C.** l'ordre des réactions est imposé pour chaque personne.
- [ ] **D.** une même personne peut ne pas traverser chaque étape.
- [ ] **E.** le soignant doit imposer rapidement l'acceptation.

Q44 — **Une patiente devient silencieuse après l'annonce. Quelles hypothèses prudentes sont recevables ?** — Moyen

- ☐ **A.** Une sidération est possible.
- ☐ **B.** Le silence prouve qu'elle a compris et accepté.
- ☐ **C.** Une réaction de protection psychique peut être en jeu.
- ☐ **D.** Il faut observer, écouter et proposer un soutien.
- ☐ **E.** Il faut immédiatement conclure à un trouble psychiatrique.

Q45 — **Dans l'accompagnement des proches lors d'une annonce…** — Difficile

- ☐ **A.** leur bouleversement peut être reconnu.
- ☐ **B.** le patient doit rester une personne sujet de la prise en charge.
- ☐ **C.** la confidentialité doit être respectée.
- ☐ **D.** les proches reçoivent systématiquement toute information sans accord.
- ☐ **E.** la défense du patient doit toujours être éliminée.

Corps, schéma et image — 5 questions

Q46 — **Le corps-objet et le corps-sujet diffèrent car…** — Facile

- ☐ **A.** le corps-objet est étudié biologiquement et médicalement.
- ☐ **B.** le corps-sujet renvoie au corps vécu et à son histoire.
- ☐ **C.** le corps-sujet se réduit aux organes mesurables.
- ☐ **D.** les deux termes désignent deux regards sur la personne.
- ☐ **E.** le corps-objet interdit toute écoute clinique.

Q47 — **Le schéma corporel désigne…** — Moyen

- ☐ **A.** des repères sensoriels et moteurs.
- ☐ **B.** la capacité de se situer et de mobiliser son corps.
- ☐ **C.** uniquement l'estime esthétique de son apparence.
- ☐ **D.** des composantes posturales.
- ☐ **E.** exactement le même concept que l'image du corps.

Q48 — **L'image du corps renvoie notamment…** — Moyen

- [ ] **A.** à une représentation subjective du corps.
- [ ] **B.** à la valeur affective et personnelle attribuée à son apparence.
- [ ] **C.** uniquement à la liste des muscles.
- [ ] **D.** à l'histoire et au regard d'autrui.
- [ ] **E.** au même sens que le schéma corporel.

Q49 — **À propos de l'amputation et du membre fantôme…** — Moyen

- [ ] **A.** un membre absent peut encore être ressenti.
- [ ] **B.** la douleur de membre fantôme peut exister.
- [ ] **C.** le vécu corporel n'est pas réduit à l'état anatomique présent.
- [ ] **D.** cette douleur permet d'accuser le patient d'inventer.
- [ ] **E.** cela prouve nécessairement une atteinte mentale.

Q50 — **Que signifie une approche psychosomatique prudente ?** — Difficile

- [ ] **A.** Considérer l'histoire et les dimensions psychiques et corporelles ensemble.
- [ ] **B.** Déduire qu'une personne a créé sa maladie par la pensée.
- [ ] **C.** Maintenir une recherche médicale des causes organiques.
- [ ] **D.** Ne pas culpabiliser le patient.
- [ ] **E.** Écarter toute dimension relationnelle.

Douleur et expérience clinique — 2 questions

Q51 — **À propos de la douleur chronique décrite par Mme Khatir, quelles propositions sont exactes ?** — Facile

- [ ] **A.** Elle persiste ou réapparaît pendant plus de trois mois.
- [ ] **B.** Elle possède uniquement une cause psychologique.
- [ ] **C.** Des dimensions biologiques, psychologiques et sociales peuvent intervenir.
- [ ] **D.** Elle impose une lésion visible pour être reconnue.
- [ ] **E.** Sa prise en charge doit tenir compte du vécu de la personne.

Q52 Quels repères permettent de distinguer les mécanismes de douleur ? — Moyen

- [ ] **A.** Une fracture douloureuse peut relever d'un mécanisme nociceptif.
- [ ] **B.** Brûlures et décharges électriques peuvent évoquer un mécanisme neuropathique.
- [ ] **C.** Une douleur sans cause organique retrouvée est nécessairement simulée.
- [ ] **D.** Le mécanisme neuropathique désigne exclusivement une douleur liée à une infection cutanée.
- [ ] **E.** Une cause encore non identifiée autorise à nier la plainte du patient.

Douleur, souffrance et vécu — 1 question

Q53 Comment distinguer souffrance psychique et douleur morale ? — Moyen

- [ ] **A.** Une souffrance psychique peut exister sans diagnostic psychiatrique caractérisé.
- [ ] **B.** La douleur morale peut qualifier une détresse très intense dans certaines dépressions graves.
- [ ] **C.** Souffrance psychique et douleur morale sont systématiquement synonymes.
- [ ] **D.** Le ressenti peut être influencé par le contexte existentiel de la personne.
- [ ] **E.** Toute souffrance psychique impose de conclure à une dépression mélancolique.

Qualité de vie et évaluation — 1 question

Q54 Comment associer maladie chronique et qualité de vie ? — Facile

- [ ] **A.** Une maladie chronique peut nécessiter un accompagnement prolongé.
- [ ] **B.** La maladie chronique exclut nécessairement une bonne qualité de vie perçue.
- [ ] **C.** La qualité de vie comporte des domaines physiques, psychologiques, sociaux et matériels.
- [ ] **D.** Le seul résultat d'un examen biologique suffit à établir la qualité de vie d'un patient.
- [ ] **E.** Le vécu et l'environnement du patient participent à l'évaluation.

Événements de vie et stress

2 questions

Q55 — Quels éléments correspondent aux distinctions présentées sur les événements de vie ?

Moyen

- [ ] **A.** Un événement de vie peut rompre rapidement une continuité dans l'existence.
- [ ] **B.** Une difficulté de vie désigne une situation problématique d'au moins quatre semaines.
- [ ] **C.** Les tracas sont nécessairement plus graves que tout événement majeur.
- [ ] **D.** Les événements en série peuvent contribuer à une exposition stressante prolongée.
- [ ] **E.** Tous les événements provoquent les mêmes réactions chez tous les patients.

Q56 — À propos de l'échelle de réajustement social de Holmes et Rahe, quelles propositions sont recevables ?

Difficile

- [ ] **A.** Il s'agit d'un outil historique de pondération d'événements de vie.
- [ ] **B.** Elle comprend une liste historique de 43 événements.
- [ ] **C.** Un score supérieur à 300 constitue un diagnostic de maladie certaine.
- [ ] **D.** Le modèle doit être nuancé par l'évaluation subjective et le contexte.
- [ ] **E.** L'échelle démontre que les mêmes événements ont toujours les mêmes effets.

Personnalité et vulnérabilité

2 questions

Q57 — Quels traits correspondent aux descriptions historiques des profils A et B ?

Moyen

- [ ] **A.** Le type A est notamment décrit par impatience et compétitivité.
- [ ] **B.** Le type B représente un profil comparativement moins compétitif et agressif.
- [ ] **C.** Le profil A établit à lui seul qu'une personne subira un infarctus.
- [ ] **D.** Les associations sanitaires historiques ont été nuancées par des études ultérieures.
- [ ] **E.** Le type B garantit l'absence de toute pathologie coronarienne.

Q58 **Au sujet du profil dit « type C », quelles propositions sont exactes ?** Difficile

- ☐ **A.** Il a été historiquement décrit par une inhibition des émotions négatives et une attitude conciliante.
- ☐ **B.** Le profil C provoque nécessairement un cancer.
- ☐ **C.** Les études sur personnalité et cancer ont donné des résultats contradictoires.
- ☐ **D.** Le soignant peut accuser le patient d'avoir causé sa maladie par son comportement.
- ☐ **E.** Une association historique n'autorise pas à affirmer une causalité.

Ressources protectrices — 2 questions

Q59 **Quelles propositions décrivent correctement l'optimisme ?** Facile

- ☐ **A.** C'est une tendance générale à anticiper des issues favorables.
- ☐ **B.** Il correspond obligatoirement à l'absence de difficultés réelles.
- ☐ **C.** Le questionnaire LOT-R est cité comme outil d'évaluation.
- ☐ **D.** Il garantit une guérison plus rapide dans toute situation.
- ☐ **E.** Il est présenté parmi les caractéristiques salutogènes possibles.

Q60 **Qu'entend-on par lieu de contrôle (locus of control) ?** Moyen

- ☐ **A.** Le contrôle interne attribue plutôt les résultats à ses actions, capacités ou efforts.
- ☐ **B.** Le contrôle externe peut faire intervenir hasard, destin ou personnes influentes.
- ☐ **C.** Il mesure uniquement la réalité objective de ce que le patient maîtrise.
- ☐ **D.** C'est une croyance généralisée concernant l'origine des événements.
- ☐ **E.** Un contrôle externe prouve que la personne refuse tous les soins.

Auto-efficacité — 1 question

Q61 **L'auto-efficacité est décrite comme…** Moyen

- ☐ **A.** la croyance en sa capacité à mobiliser des ressources pour réussir une tâche.
- ☐ **B.** un sentiment identique à la seule quantité d'aide sociale reçue.
- ☐ **C.** une ressource susceptible de soutenir l'ajustement à une situation.
- ☐ **D.** la certitude de ne rencontrer aucun obstacle.
- ☐ **E.** une notion explorée par une échelle attribuée à Jerusalem et Schwarzer.

Application clinique des concepts

1 question

Q62 — Difficile

Un patient dit : « Ma famille m'aide, mais je ne pense pas réussir à réaliser mes soins seul. » Quelles analyses sont justifiées ?

- ☐ **A.** Le soutien social disponible peut être présent alors que l'auto-efficacité est faible.
- ☐ **B.** Le soignant doit en déduire automatiquement que le patient manque de volonté.
- ☐ **C.** Il est pertinent d'explorer des objectifs réalisables et les ressources du patient.
- ☐ **D.** Le soutien reçu et la confiance en ses capacités sont exactement la même notion.
- ☐ **E.** Une situation doit être analysée sans attribuer d'emblée une étiquette psychologique définitive.

Corrigés argumentés

La correction associe les réponses exactes et l'explication du cours.

Santé et qualité de vie — 6 questions

Q01 — La psychologie de la santé étudie notamment…

Bonnes réponses : B, C, E — À écarter : A, D

La psychologie de la santé adopte une approche biopsychosociale : elle relie facteurs personnels, sociaux, prévention, vécu et trajectoire de soin. Elle ne se limite ni à l'organe ni au médicament.

Q02 — Que faut-il retenir de la définition de la santé formulée par l'OMS ?

Bonnes réponses : A, C, E — À écarter : B, D

La définition de l'OMS dépasse l'absence d'affection et prend en compte trois dimensions ; le cours en discute la dimension idéale et relativement statique.

Q03 — À propos de la santé perçue, quelles propositions sont justes ?

Bonnes réponses : A, C, D — À écarter : B, E

La santé perçue appartient au point de vue du sujet ; elle n'est pas réductible aux mesures biomédicales.

Q04 — Quelles dimensions font partie de la qualité de vie ?

Bonnes réponses : A, B, C — À écarter : D, E

La qualité de vie comporte des dimensions physique, psychique, sociale et environnementale ; sa mesure ne peut se résumer aux constantes ou au traitement.

Q05 — Une personne vit avec une maladie chronique et dit garder une bonne qualité de vie. Que peut-on conclure ?

Bonnes réponses : A, C, E — À écarter : B, D

La qualité de vie ne dépend pas mécaniquement de la présence d'un diagnostic : autonomie, sens, soutien et ressources comptent.

Q06 — Lorsqu'une infirmière et un patient évaluent différemment la santé de ce dernier…

Bonnes réponses : A, C, E À écarter : B, D

Comparer sans hiérarchisation automatique permet de comprendre les écarts de perspectives et d'adapter l'accompagnement.

Maladie, douleur et représentations — 6 questions

Q07 — Dans la distinction disease / illness / sickness, illness désigne…

Bonnes réponses : A, C À écarter : B, D, E

Illness renvoie à ce que le patient éprouve et raconte ; disease renvoie à la dimension biomédicale, sickness à la dimension sociale.

Q08 — La notion de sickness se rapporte notamment…

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Sickness décrit le statut et les conséquences sociales de la maladie ; elle diffère des processus biologiques et de l'expérience intime.

Q09 — Quelles affirmations correspondent à l'approche de la douleur présentée ?

Bonnes réponses : A, C, E À écarter : B, D

Le cours insiste sur l'expérience sensorielle et émotionnelle : la douleur existe aussi sans lésion objectivable.

Q10 — Un patient exprime une douleur sans anomalie identifiée. Quelle posture est adaptée ?

Bonnes réponses : A, C, E À écarter : B, D

L'absence de lésion visible n'annule pas la douleur. Elle n'autorise ni accusation de simulation ni réduction psychologique automatique.

Q11 — Les représentations personnelles de la maladie peuvent concerner…

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Les représentations explorent cause, identité, conséquences, temporalité, contrôle et traitement ; ce sont des croyances du patient.

Q12 — Une personne associe sa maladie à une épreuve familiale et refuse un soin. Que doit faire le soignant ?

Bonnes réponses : A, C, E À écarter : B, D

Comprendre la représentation ne signifie pas la valider comme étiologie ; cela permet d'identifier les obstacles et de dialoguer.

Déterminants et modèle intégratif — 4 questions

Q13 — Quels niveaux sont articulés dans le modèle intégratif de la santé ?

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Il distingue des facteurs de risque initiaux, l'évaluation et les stratégies de la personne, puis les conséquences d'ajustement.

Q14 — Un facteur de risque…

Bonnes réponses : A, C, D À écarter : B, E

La notion est probabiliste et contextuelle ; antécédents, vulnérabilité, déclencheurs et protection ne se confondent pas.

Q15 — Parmi les éléments suivants, lesquels sont des déterminants socio-environnementaux abordés ?

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Les conditions matérielles, sociales, professionnelles et l'accès au soin influencent les trajectoires de santé.

Q16 — Une personne fait face à la même contrainte qu'une autre mais la vit différemment. Qu'est-ce qui l'explique dans ce modèle ?

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Les processus transactionnels modulent l'effet des facteurs initiaux ; le vécu est dynamique, non mécanique.

Soutien social

5 questions

Q17 — Le réseau social d'une personne correspond…

Bonnes réponses : A, C

À écarter : B, D, E

Un réseau est un ensemble de liens ; la taille du réseau ne prouve pas le caractère adapté du soutien reçu ou perçu.

Q18 — Le soutien social perçu désigne…

Bonnes réponses : A, C, E

À écarter : B, D

Le soutien perçu est une évaluation subjective de la disponibilité et de l'adéquation de l'aide, distincte du soutien reçu.

Q19 — Le soutien social reçu et le soutien mobilisé se distinguent parce que…

Bonnes réponses : A, B, E

À écarter : C, D

Le reçu est l'aide effective ; le mobilisé désigne des efforts pour obtenir de l'aide ; le perçu renseigne le sentiment d'être soutenu.

Q20 — Quelles situations correspondent à des formes de soutien social ?

Bonnes réponses : A, B, C

À écarter : D, E

Le soutien peut être instrumental, émotionnel, informatif ou lié à la reconnaissance et à l'intégration sociale.

Q21 — Une personne a beaucoup de connaissances mais dit « personne ne m'aide quand ça va mal ». Quelles pistes sont pertinentes ?

Bonnes réponses : A, C, D

À écarter : B, E

Le soutien social n'est pas une simple quantité de liens : sa disponibilité, sa pertinence et son vécu méritent une exploration.

Vulnérabilité et résilience

5 questions

Q22 — La vulnérabilité peut dépendre…

Bonnes réponses : A, B, C

À écarter : D, E

Le cours distingue les composantes personnelles et environnementales : elles interagissent sans condamnation mécanique.

Q23 — La résilience présentée en cours…

Bonnes réponses : A, C, D

À écarter : B, E

Le concept concerne le développement et l'ajustement malgré l'adversité, sans nier l'épreuve ni promettre une guérison émotionnelle.

Q24 — À propos des formulations de Rutter et de Cyrulnik…

Bonnes réponses : A, C, D

À écarter : B, E

Mme Katir demande les définitions entières, en phrases rédigées. Les différentes références décrivent la construction malgré des conditions adverses.

Q25 — Les travaux longitudinaux d'Emmy Werner sont évoqués pour…

Bonnes réponses : A, C, E

À écarter : B, D

Le repère historique sert à montrer des trajectoires différenciées, influencées par les ressources personnelles et protectrices.

Q26 — Que peut-on affirmer au sujet des traits de personnalité et de l'hostilité ?

Bonnes réponses : A, B, D

À écarter : C, E

Le cours mobilise ces notions comme facteurs pouvant influer sur le stress et les relations, sans causalité individuelle simpliste.

Stress et coping

7 questions

Q27 — Dans le modèle transactionnel du stress, l'évaluation primaire porte sur…

Bonnes réponses : A, C, E À écarter : B, D

L'évaluation primaire caractérise ce que représente l'événement ; les ressources sont évaluées principalement lors de l'évaluation secondaire.

Q28 — L'évaluation secondaire concerne notamment…

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Elle examine les moyens d'action et les ressources perçues, sans garantir un contrôle complet.

Q29 — Le contrôle perçu…

Bonnes réponses : A, C, D À écarter : B, E

Le contrôle perçu désigne un sentiment de capacité d'action ; il peut soutenir l'ajustement sans supprimer les limites réelles.

Q30 — Le coping centré sur le problème peut consister à…

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Ce coping vise à agir sur la situation ou à renforcer les ressources pour y faire face.

Q31 — Le coping centré sur l'émotion peut inclure…

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Le coping émotionnel cherche à modifier la manière de vivre l'émotion ; la réévaluation positive ne supprime pas les faits.

Q32 — Le coping centré sur la recherche de soutien comprend…

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Ce registre rassemble des efforts actifs de recherche d'un soutien émotionnel, informatif ou pratique.

Q33 — Comment distinguer les stratégies de coping et les mécanismes de défense ?

Bonnes réponses : A, B, D À écarter : C, E

Coping et défense sont des cadres différents, et l'évaluation de leurs effets tient compte du contexte, de la durée et des conséquences.

Angoisse et mécanismes de défense — 8 questions

Q34 — Les mécanismes de défense ont principalement pour fonction…

Bonnes réponses : A, C, D À écarter : B, E

Ils peuvent avoir une fonction protectrice dans l'épreuve ; ils ne sont pas des indices de faute ou de mauvaise volonté.

Q35 — Un patient paraît dans le déni après une annonce. Quelles attitudes sont cohérentes avec le cours ?

Bonnes réponses : A, C, D À écarter : B, E

Le déni peut amortir un choc ; il doit être observé avec discernement et pris en compte s'il compromet des soins essentiels.

Q36 — La projection peut être décrite comme…

Bonnes réponses : A, C, E À écarter : B, D

La projection déplace vers autrui certains contenus psychiques ; son interprétation ne se déduit toutefois pas d'un reproche isolé.

Q37 — À propos de la régression et de la rationalisation…

Bonnes réponses : A, B, D À écarter : C, E

La régression et la rationalisation sont deux mécanismes de défense différents, mobilisables face à des conflits ou à l'angoisse.

Q38 — Quelle distinction est correcte entre isolation, refoulement et dénégation ?

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Les trois mécanismes agissent différemment sur le rapport aux affects et représentations. On ne pose pas de diagnostic sur une seule parole.

Q39 — À propos de l'activisme, de la combativité et du retrait apathique…

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

Ces mécanismes peuvent protéger contre l'angoisse ; leur fonction dépend du contexte et ne constitue jamais une garantie médicale.

Q40 — L'affiliation présentée comme mécanisme de défense…

Bonnes réponses : A, C, D À écarter : B, E

Dans ce chapitre, l'affiliation concerne un mouvement de recherche de soutien protecteur face à l'angoisse, différent de la psychosociologie.

Q41 — La sublimation et l'humour sont abordés dans les défenses. Quelles propositions sont justes ?

Bonnes réponses : A, B, D À écarter : C, E

La sublimation peut être comprise selon deux acceptions ; l'humour appliqué à soi-même est une modalité particulière de transformation de ce qui provoque de l'angoisse.

Annonce du diagnostic — 4 questions

Q42 — La définition complète de l'annonce du diagnostic donnée par Mme Katir comporte…

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

La définition inclut explicitement le choc, l'épreuve et le traumatisme psychique potentiel, en plus de l'acte d'annonce.

Q43 — Concernant les réactions décrites après une annonce…

Bonnes réponses : A, B, D À écarter : C, E

Les réactions présentées sont des repères pédagogiques, pas un calendrier universel ni un moyen d'étiqueter les patients.

Q44 — Une patiente devient silencieuse après l'annonce. Quelles hypothèses prudentes sont recevables ?

Bonnes réponses : A, C, D À écarter : B, E

Le silence peut notamment refléter une sidération ; on ne peut pas en déduire une compréhension, une émotion certaine ou un diagnostic.

Q45 — Dans l'accompagnement des proches lors d'une annonce…

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

L'impact relationnel est important, mais il ne retire ni la place du patient ni les exigences de respect et de confidentialité.

Corps, schéma et image — 5 questions

Q46 — Le corps-objet et le corps-sujet diffèrent car…

Bonnes réponses : A, B, D À écarter : C, E

Le cours oppose deux perspectives complémentaires : corps observable et corps singulier vécu dans une histoire psychique et relationnelle.

Q47 — Le schéma corporel désigne…

Bonnes réponses : A, B, D À écarter : C, E

Le schéma corporel est sensorimoteur et postural ; l'image du corps est une représentation subjective et affective.

Q48 — L'image du corps renvoie notamment…

Bonnes réponses : A, B, D À écarter : C, E

Elle associe représentation psychique, affects, identité et relations, au-delà des repères sensorimoteurs.

Q49 — À propos de l'amputation et du membre fantôme…

Bonnes réponses : A, B, C À écarter : D, E

L'exemple illustre un décalage possible entre l'intégrité anatomique et l'expérience corporelle vécue.

Q50 — Que signifie une approche psychosomatique prudente ?

Bonnes réponses : A, C, D À écarter : B, E

Le cours invite à une lecture globale sans causalité psychique abusive et sans renoncer aux soins somatiques.

Douleur et expérience clinique

2 questions

Q51 — À propos de la douleur chronique décrite par Mme Khatir, quelles propositions sont exactes ?

Bonnes réponses : A, C, E

À écarter : B, D

Le document 1 définit la douleur chronique par une durée supérieure à trois mois et souligne sa nature multifactorielle. Une douleur peut être réelle sans lésion objectivable ; le vécu doit être évalué.

Q52 — Quels repères permettent de distinguer les mécanismes de douleur ?

Bonnes réponses : A, B

À écarter : C, D, E

Le document 1 associe la nociception aux agressions tissulaires et le mécanisme neuropathique à des sensations telles que brûlures ou décharges. L'absence de cause retrouvée ne signifie pas simulation.

Douleur, souffrance et vécu

1 question

Q53 — Comment distinguer souffrance psychique et douleur morale ?

Bonnes réponses : A, B, D

À écarter : C, E

Le support distingue le mal-être psychique, qui ne suffit pas à diagnostiquer une maladie, de la douleur morale de la sémiologie psychiatrique. Une situation difficile n'autorise pas un diagnostic automatique.

Qualité de vie et évaluation

1 question

Q54 — Comment associer maladie chronique et qualité de vie ?

Bonnes réponses : A, C, E

À écarter : B, D

La prise en charge d'une affection chronique s'inscrit souvent dans la durée. La qualité de vie demeure subjective et multidimensionnelle : les résultats biologiques seuls ne la définissent pas.

Événements de vie et stress

2 questions

Q55 — Quels éléments correspondent aux distinctions présentées sur les événements de vie ?

Bonnes réponses : A, B, D

À écarter : C, E

Le document 2 distingue événements, difficultés durables, incidents mineurs et événements répétés. L'impact dépend aussi de l'interprétation et des ressources de la personne.

Q56 — À propos de l'échelle de réajustement social de Holmes et Rahe, quelles propositions sont recevables ?

Bonnes réponses : A, B, D À écarter : C, E

La version historique de 1967 pondère 43 événements et évoque un risque accru au-delà de 300 points, mais le cours remet en cause tout lien strictement causal et toute prédiction certaine chez un individu.

Personnalité et vulnérabilité — 2 questions

Q57 — Quels traits correspondent aux descriptions historiques des profils A et B ?

Bonnes réponses : A, B, D À écarter : C, E

Les types A et B sont des modèles historiques de comportements. Les associations avec la maladie coronarienne ont été nuancées par les études ultérieures. Aucun profil n'autorise une certitude clinique individuelle.

Q58 — Au sujet du profil dit « type C », quelles propositions sont exactes ?

Bonnes réponses : A, C, E À écarter : B, D

Le document 2 décrit le profil C et insiste sur les résultats contradictoires de la recherche : il est interdit de transformer cette hypothèse en cause médicale ni de culpabiliser les personnes.

Ressources protectrices — 2 questions

Q59 — Quelles propositions décrivent correctement l'optimisme ?

Bonnes réponses : A, C, E À écarter : B, D

Le document 2 définit l'optimisme comme un style cognitif global et présente le LOT-R. Il s'agit d'un facteur de protection potentiel, jamais d'une garantie thérapeutique.

Q60 — Qu'entend-on par lieu de contrôle (locus of control) ?

Bonnes réponses : A, B, D À écarter : C, E

Le lieu de contrôle (Rotter) porte sur l'attribution subjective des événements à des causes internes ou externes. Il ne prouve ni un contrôle réel ni la qualité de l'adhésion aux soins.

Auto-efficacité

1 question

Q61 — L'auto-efficacité est décrite comme…

Bonnes réponses : A, C, E

À écarter : B, D

Le document 2 insiste sur la croyance en la capacité d'action, distincte du réseau social et de la garantie de réussite, et mentionne l'échelle de Jerusalem et Schwarzer (1992).

Application clinique des concepts

1 question

Q62 — Un patient dit : « Ma famille m'aide, mais je ne pense pas réussir à réaliser mes soins seul. » Quelles analyses sont justifiées ?

Bonnes réponses : A, C, E

À écarter : B, D

Le soutien social, l'auto-efficacité et le contrôle sont des notions distinctes. L'IDE peut explorer les besoins, adapter l'aide et soutenir une progression réaliste sans jugement.